JEU DE 52 CARTES + 2 JOKERS · ÉTUDIANTS IPA, NIVEAU MASTER

Raisonnement clinique en prévention

Un jeu de cartes classique dont chaque couleur correspond à une étape du raisonnement clinique et chaque valeur à une situation de prévention suivie à travers un même patient. Réunir les quatre cartes d'une valeur, c'est dérouler un raisonnement complet, du recueil des données au suivi.

Les 4 couleurs = 4 étapes

- ♥ **Cœur — Recueillir**
  Anamnèse, écoute, contexte de vie
- ♦ **Carreau — Repérer & hypothèses**
  Outils de repérage, scores, hypothèses diagnostiques
- ♣ **Trèfle — Vérifier**
  Examen clinique, examens complémentaires, diagnostics différentiels
- ♠ **Pique — Agir & suivre**
  Décision partagée, intervention, orientation, suivi

Les 13 valeurs = 13 thématiques

2	Sevrage tabagique
3	Alcool
4	Cannabis & autres substances
5	Hypertension artérielle
6	Diabète de type 2
7	Obésité & activité physique
8	Syndrome dépressif
9	Dénutrition de la personne âgée
10	Carence martiale
V	BPCO : repérage
D	Dépistage des cancers
R	Fragilité & chutes
A	Risque cardiovasculaire global

Anatomie d'une carte

Vignette (situation du patient, qui évolue d'une couleur à l'autre) · **Question** posée au joueur · **Repères attendus**, lus uniquement par celui qui pose la question pour valider la réponse. Les repères ne sont pas exhaustifs : une argumentation pertinente non listée est valorisée.

Mode 1 · Le Carré clinique

3 à 6 joueurs · 45 à 60 min

1. Distribuer 6 cartes par joueur ; le reste forme la pioche.
2. À son tour, un joueur demande à un autre une carte précise pour avancer un carré (« le Trèfle de la carence martiale »).
3. Si l'autre la possède, il lit la vignette et la question ; le demandeur répond. Réponse validée au regard des repères → il prend la carte et rejoue. Sinon, ou si la carte n'est pas en jeu, il pioche et la main passe.
4. Carré complet : le joueur le pose et présente en 2 minutes une **synthèse orale** du raisonnement (recueil → hypothèses → vérification → action) : **4 points**. +1 point s'il le relie à une autre thématique (tabac et BPCO, diabète et risque cardiovasculaire…).
5. Fin de partie quand la pioche est vide : le plus de points l'emporte.

Les jokers

Drapeau rouge et **Patient partenaire** remplacent une carte manquante d'un carré, à condition de relever le défi inscrit dessus.

Mode 2 · Le Fil rouge

Travaux dirigés · groupes de 4 à 8 · 20 min par cas

L'animateur extrait les 4 cartes d'une thématique et les révèle dans l'ordre ♥ ♦ ♣ ♠. Le groupe raisonne à voix haute à chaque étape avant de découvrir la suivante, puis compare avec les repères.

Mode 3 · Le Tirage éclair

Révision en binôme · 10 à 15 min

Mélanger, tirer une carte, lire la vignette et la question ; le partenaire répond en 1 minute. Comparer aux repères, puis inverser les rôles.

Pistes de débriefing

- Hiérarchisation des hypothèses, données discriminantes
- Biais cognitifs : ancrage, fermeture prématurée, biais de disponibilité
- Place du patient : préférences, littératie, décision partagée
- Cadre d'exercice IPA : prescription, orientation, coordination

Impression : A4, recto verso (retournement bord long), échelle 100 %, papier 250 à 300 g/m² ; découper le long des repères de coupe. Pages impaires = faces, pages paires = dos.
Avertissement : contenus fondés sur les recommandations disponibles en octobre 2026 (HAS, Santé publique France, sociétés savantes, ESC). Ils sont à vérifier et à actualiser par l'équipe pédagogique avant chaque usage.

2 ♥ CŒUR · RECUEILLIR

Sevrage tabagique

> *M. D., 52 ans, chauffeur routier, fumeur depuis l'âge de 16 ans, vient pour le suivi de son HTA. Il tousse le matin.*

? Quelles données recueillez-vous pour caractériser son tabagisme ?

REPÈRES ATTENDUS

- Consommation en paquets-années (paquets/jour × années)
- Délai de la 1re cigarette au réveil, nombre de cigarettes/jour
- Autres produits : vapoteuse, cannabis, alcool
- Tentatives d'arrêt antérieures, aides utilisées, causes de rechute
- Motivation et ambivalence (réglette 0 à 10)

2 ♥

2 ♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Sevrage tabagique

> *Il fume 25 cigarettes/jour, la première dans les 5 minutes après le réveil. « J'aimerais arrêter, mais pas maintenant. »*

? Comment interprétez-vous sa dépendance et son niveau de motivation ?

REPÈRES ATTENDUS

- Fagerström simplifié : ≤ 5 min (3 pts) + 21–30 cig/j (2 pts) = 5/6 → dépendance forte
- Stade de contemplation (modèle de Prochaska et DiClemente)
- Ambivalence à explorer, non à combattre (entretien motivationnel)
- Hypothèse associée : BPCO débutante (toux matinale)

2 ♦

2 ♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Sevrage tabagique

> *Vous souhaitez objectiver le tabagisme et ses conséquences avant d'en reparler avec lui.*

? Quelles mesures ou quels examens sont pertinents ?

REPÈRES ATTENDUS

- Mesure du CO expiré : objectivation et levier motivationnel
- Spirométrie ou mini-spiromètre : VEMS/CVF < 0,7 → BPCO
- Évaluation du risque cardiovasculaire global (PA, lipides, glycémie)
- Repérage anxiété-dépression (échelle HAD) : facteur de rechute

2 ♣

2 ♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Sevrage tabagique

> *Deux mois plus tard, M. D. fixe une date d'arrêt dans 15 jours.*

? Quel accompagnement proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Substituts nicotiniques à dose suffisante, souvent patch + forme orale (prescriptibles par l'infirmier·e, remboursés)
- Entretien motivationnel et soutien comportemental
- Tabac info service (39 89, appli), Mois sans tabac
- Anticiper les situations à risque (cabine du camion), la prise de poids
- Suivi rapproché, ajustement des doses (signes de sous- ou surdosage)

2 ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

3 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Alcool

> *Mme L., 45 ans, cadre commerciale, consulte pour une fatigue et des troubles du sommeil depuis plusieurs mois.*

? Comment abordez-vous la question de l'alcool ?

REPÈRES ATTENDUS

- Question systématique, non jugeante, intégrée aux habitudes de vie
- Questionnaire AUDIT-C : fréquence, quantité, épisodes ≥ 6 verres
- Contexte : stress professionnel, usage « pour dormir » ou « décompresser »
- Retentissement : sommeil, travail, famille, conduite automobile

3 ♥

3 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Alcool

> *Elle boit 3 à 4 verres de vin chaque soir, 6 verres ou plus le week-end. AUDIT-C : 9.*

? Comment qualifiez-vous cette consommation ?

REPÈRES ATTENDUS

- Au-delà des repères à moindre risque : max. 10 verres standard/semaine, max. 2 par jour, des jours sans alcool
- AUDIT-C positif (seuil ≥ 3 chez la femme) → compléter par l'AUDIT à 10 questions
- Hypothèses : usage à risque, usage nocif, trouble de l'usage (DSM-5)
- Insomnie et fatigue possiblement liées à l'alcool

3 ♦

3 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Alcool

> *Vous complétez votre évaluation clinique.*

? Quels éléments cliniques et biologiques recherchez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Signes de dépendance : besoin matinal, tremblements, échecs de réduction
- GGT, VGM, transaminases, CDT : marqueurs d'appoint, jamais diagnostiques seuls
- Syndrome anxio-dépressif associé
- Comorbidités : HTA, tabac, prise d'hypnotiques

3 ♣

3 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Alcool

> *Mme L. ne présente pas de signe de dépendance physique. Elle se dit « prête à lever le pied ».*

? Quelle intervention mettez-vous en œuvre ?

REPÈRES ATTENDUS

- Intervention brève (RPIB) : restitution, information, conseil, objectif négocié
- Agenda de consommation, objectifs de réduction réalistes
- Hygiène du sommeil plutôt qu'un hypnotique
- Réévaluation à 1 mois ; CSAPA ou addictologie si échec
- Si dépendance : sevrage encadré (vitamine B1, prévention du syndrome de sevrage)

3 ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

4 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Cannabis & autres substances

> *Lucas, 19 ans, étudiant, vient pour un certificat de sport. Ses résultats universitaires ont chuté.*

? Comment créez-vous les conditions d'un repérage chez ce jeune adulte ?

REPÈRES ATTENDUS

- Entretien confidentiel, non jugeant, questions ouvertes
- Grille psychosociale HEEADSSS : habitat, études, activités, drogues, sexualité, humeur/suicide, sécurité
- Polyconsommations : cannabis, alcool, protoxyde d'azote, cocaïne, écrans
- Contexte : isolement, sommeil, entourage

♥ 4

4 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Cannabis & autres substances

> *Il fume 3 joints par jour, dès le matin, « pour être calme ». Il a abandonné son club de foot.*

? Quel outil de repérage utilisez-vous ? Quelles hypothèses formulez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- CAST (Cannabis Abuse Screening Test) : score ≥ 7 → usage problématique probable
- Trouble de l'usage du cannabis ; usage auto-thérapeutique d'une anxiété
- Désinvestissement scolaire et social
- Ne pas méconnaître un trouble psychiatrique émergent

♦ 4

4 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Cannabis & autres substances

> *Lucas dit aussi « entendre des choses » parfois, après avoir fumé.*

? Que recherchez-vous pour affiner votre raisonnement ?

REPÈRES ATTENDUS

- Symptômes psychotiques : hallucinations, idées de persécution, désorganisation
- Anxiété, dépression, idées suicidaires
- Antécédents psychiatriques familiaux
- Complications somatiques : respiratoires, syndrome d'hyperémèse cannabinoïde
- Dépistage urinaire : seulement avec accord, intérêt diagnostique limité

♣ 4

4 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Cannabis & autres substances

> *Les symptômes sont brefs et strictement liés à la consommation. Lucas accepte d'en parler.*

? Quelle prise en charge proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Intervention brève, entretien motivationnel, réduction des risques
- Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) : gratuite et confidentielle
- Avis psychiatrique rapide si symptômes psychotiques persistants
- Drogues info service : 0 800 23 13 13
- Suivi régulier ; implication de l'entourage s'il le souhaite

♠ 4

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

5 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Hypertension artérielle

Mme B., 58 ans, ménopausée, a une PA à 152/94 mmHg lors d'une consultation de routine.

? Quelles données recueillez-vous à l'anamnèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Antécédents personnels et familiaux cardiovasculaires et rénaux
- Facteurs de risque : tabac, diabète, dyslipidémie, sédentarité, surpoids
- Sel, alcool, réglisse ; médicaments (AINS, corticoïdes, décongestionnants)
- Symptômes : céphalées, troubles visuels, douleur thoracique, dyspnée
- Ronflements, somnolence diurne (apnées du sommeil)

Raisonnement clinique en prévention · IPA

5 ♥

5 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Hypertension artérielle

Elle est asymptomatique. Trois mesures au cabinet : 150/92, 148/94 et 152/90 mmHg.

? Quelle est votre hypothèse et comment la confirmez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Hypothèse : HTA de grade 1 (140–159 / 90–99 mmHg)
- Confirmation hors cabinet avant tout traitement : automesure (règle des 3 : 3 mesures matin et soir, 3 jours) ou MAPA
- Seuils : automesure ≥ 135/85 ; MAPA des 24 h ≥ 130/80
- Écarter un effet blouse blanche

Raisonnement clinique en prévention · IPA

5 ♦

5 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Hypertension artérielle

L'automesure confirme une moyenne de 142/88 mmHg.

? Quel bilan initial réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Créatininémie avec estimation du DFG, kaliémie, natrémie
- Glycémie à jeun, bilan lipidique
- Recherche de protéinurie (ratio albuminurie/créatininurie)
- ECG de repos
- IMC, tour de taille, souffles, pouls périphériques ; risque cardiovasculaire global

Raisonnement clinique en prévention · IPA

5 ♣

5 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Hypertension artérielle

Le bilan est normal. Mme B. préfère « essayer sans médicament d'abord ».

? Comment construisez-vous le plan de soins ?

REPÈRES ATTENDUS

- Décision partagée : mesures hygiéno-diététiques seules quelques mois si le risque est faible
- Moins de sel, activité physique régulière, perte de poids, moins d'alcool
- Objectif : < 140/90 au cabinet, < 135/85 en automesure
- Réévaluation puis traitement si objectif non atteint ; éducation à l'automesure
- Orientation urgente si PA ≥ 180/110 avec signes d'atteinte d'organe

Raisonnement clinique en prévention · IPA

5 ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

6 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Diabète de type 2

M. K., 55 ans, IMC 31 kg/m², père diabétique, sédentaire. Il vient pour un bilan de santé.

? Quels éléments recueillez-vous pour évaluer son risque de diabète ?

REPÈRES ATTENDUS

- Facteurs de risque : âge > 45 ans, surpoids, hérédité, sédentarité, origine géographique
- Antécédents : HTA, dyslipidémie ; diabète gestationnel chez la femme
- Symptômes : polyurie, polydipsie, amaigrissement, infections à répétition
- Alimentation, activité physique, contexte socio-professionnel

6 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Diabète de type 2

Score FINDRISC : 16. Aucun symptôme.

? Quelle hypothèse ? Quelle démarche de dépistage ?

REPÈRES ATTENDUS

- FINDRISC 15–20 : risque élevé de diabète à 10 ans
- Dépistage par glycémie veineuse à jeun
- Diabète : glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7 mmol/L) à 2 reprises, ou ≥ 2 g/L à tout moment avec symptômes
- Hyperglycémie modérée à jeun : 1,10 à 1,25 g/L

6 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Diabète de type 2

Deux glycémies à jeun à 1,38 et 1,41 g/L : le diagnostic de diabète de type 2 est posé.

? Quel bilan initial et de retentissement organisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- HbA1c, bilan lipidique, créatininémie + DFG, ratio albuminurie/créatininurie
- ECG ; examen des pieds (monofilament, pouls, déformations)
- Dépistage de la rétinopathie (rétinographie)
- PA, IMC, tour de taille ; examen bucco-dentaire
- Risque cardiovasculaire global

6 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Diabète de type 2

HbA1c : 7,4 %. M. K. se dit « débordé par toutes ces informations ».

? Quelle stratégie d'éducation et de suivi proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Éducation thérapeutique centrée sur ses priorités, à son rythme
- Objectif individualisé, le plus souvent HbA1c ≤ 7 %
- Mode de vie + metformine en 1re intention (sauf contre-indication)
- HbA1c tous les 3 mois ; pieds, reins, yeux selon le calendrier recommandé
- Activité physique adaptée ; diététicien·ne ; podologue selon le grade

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

7 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Obésité & activité physique

Mme T., 38 ans, mère de 3 enfants, IMC 34 kg/m². Elle demande « un régime efficace ».

? Comment explorez-vous la situation, au-delà du poids ?

REPÈRES ATTENDUS

- Histoire pondérale : début, fluctuations, régimes antérieurs (effet yo-yo)
- Comportement alimentaire : grignotages, compulsions, restrictions
- Activité physique et sédentarité (temps assis, écrans)
- Sommeil, stress, contexte psychosocial, vécu de stigmatisation
- Attentes et motivation de la patiente

7 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Obésité & activité physique

Tour de taille : 98 cm. Elle décrit des prises alimentaires importantes le soir, avec perte de contrôle.

? Quelles hypothèses formulez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Obésité de grade 1 (IMC 30–34,9) avec obésité abdominale (≥ 88 cm chez la femme)
- Hyperphagie boulimique à explorer
- Comorbidités : HTA, diabète, apnées du sommeil, stéatose hépatique, arthrose
- Causes secondaires : médicaments, hypothyroïdie

7 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Obésité & activité physique

Vous complétez le bilan.

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- PA, glycémie à jeun, bilan lipidique, transaminases
- TSH si signes cliniques évocateurs
- Repérage des apnées du sommeil (questionnaire STOP-BANG)
- Condition physique : test de marche de 6 minutes
- Repérage anxiété-dépression

7 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Obésité & activité physique

Mme T. voudrait « bouger plus » mais dit ne pas avoir le temps.

? Quel plan d'action co-construisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Objectifs réalistes : – 5 à 10 % du poids, priorité à la qualité de vie
- Activité progressive vers 150 min/semaine d'intensité modérée ; moins de temps assis
- Prescription d'activité physique adaptée, Maison sport-santé
- Pas de régime restrictif ; accompagnement diététique
- Orientation spécialisée si hyperphagie confirmée ; parcours obésité gradué

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

8 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Syndrome dépressif

M. R., 63 ans, récemment retraité, veuf depuis un an, suivi pour un diabète. Il dit « ne plus avoir goût à rien ».

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Humeur et anhédonie : durée, intensité, retentissement
- Événements de vie : deuil, retraite, isolement
- Sommeil, appétit, poids, énergie, concentration
- Consommation d'alcool et de médicaments
- Ressources : entourage, activités, soutiens

Raisonnement clinique en prévention · IPA

♥ 8

8 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Syndrome dépressif

PHQ-2 positif. Au PHQ-9, il obtient 16.

? Comment interprétez-vous ce résultat ? Que devez-vous évaluer impérativement ?

REPÈRES ATTENDUS

- PHQ-9 de 15 à 19 : symptômes dépressifs modérément sévères
- DSM-5 : ≥ 5 symptômes depuis ≥ 2 semaines, dont humeur dépressive ou anhédonie
- Risque suicidaire systématique (idées, scénario, moyens) : homme âgé, veuf, isolé
- Différentiels : deuil compliqué, trouble bipolaire (épisodes d'exaltation antérieurs)

Raisonnement clinique en prévention · IPA

♦ 8

8 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Syndrome dépressif

Il n'a pas d'idée suicidaire actuelle. Il est très fatigué et a pris 3 kg.

? Quels diagnostics différentiels ou associés recherchez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Hypothyroïdie (TSH)
- Anémie (NFS), déséquilibre du diabète (HbA1c)
- Troubles cognitifs débutants (MMSE si plainte)
- Iatrogénie : bêtabloquants, corticoïdes…
- Trouble de l'usage d'alcool associé

Raisonnement clinique en prévention · IPA

♣ 8

8 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Syndrome dépressif

Un épisode dépressif caractérisé d'intensité modérée est retenu.

? Quelle prise en charge et quel suivi organisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Information, alliance thérapeutique, décision partagée
- Psychothérapie (dispositif Mon soutien psy) et/ou antidépresseur ISRS, selon le cadre de prescription
- Lutte contre l'isolement : activités, associations, entourage
- Réévaluation à 2–4 semaines ; vigilance suicidaire en début de traitement
- Plan de sécurité ; numéro national de prévention du suicide : 3114

Raisonnement clinique en prévention · IPA

♠ 8

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

9 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Dénutrition de la personne âgée

Mme V., 82 ans, vit seule à domicile. Sa fille signale qu'elle « flotte dans ses vêtements ».

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Poids actuel, poids habituel, rapidité de la perte
- Appétit, nombre de repas, courses et préparation des repas
- État bucco-dentaire, troubles de la déglutition
- Pathologies, polymédication, humeur, cognition
- Autonomie (ADL/IADL), aides en place, isolement

9 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Dénutrition de la personne âgée

Poids 48 kg (52 kg il y a 6 mois), IMC 20,5 kg/m². Elle mange la moitié de ses repas depuis 3 semaines.

? La dénutrition est-elle confirmée ? De quel degré ?

REPÈRES ATTENDUS

- Critère phénotypique : IMC < 22 (≥ 70 ans) ; la perte de 7,7 % en 6 mois ne suffit pas seule
- Critère étiologique : prise alimentaire réduite ≥ 50 % pendant plus d'une semaine
- HAS 2021 : 1 critère phénotypique + 1 étiologique → dénutrition confirmée
- Modérée à ce stade ; sévère si IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou albuminémie ≤ 30 g/L

9 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Dénutrition de la personne âgée

Vous recherchez les causes et évaluez le retentissement.

? Quels éléments cliniques et biologiques explorez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Albuminémie (critère de sévérité, à interpréter avec la CRP)
- Force de préhension, vitesse de marche (sarcopénie)
- MNA (Mini Nutritional Assessment)
- Causes : dépression, troubles cognitifs, pathologie digestive ou cancéreuse, dents, iatrogénie
- NFS, ionogramme, fonction rénale, vitamine D

9 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Dénutrition de la personne âgée

Albuminémie 33 g/L, pas de cause organique évidente. Mme V. est isolée depuis le décès de son mari.

? Quel plan d'intervention proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Alimentation enrichie et fractionnée, collations, plaisir de manger
- Compléments nutritionnels oraux si besoin, adaptés à ses goûts
- Portage de repas, aide à domicile, repas partagés (rompre l'isolement)
- Soins dentaires ; activité physique pour préserver le muscle
- Pesée mensuelle, réévaluation à 1 mois, coordination avec le médecin et la famille

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

10 ♥ CŒUR · RECUEILLIR

Carence martiale

Mme N., 34 ans, végétarienne, consulte pour une fatigue persistante et un essoufflement à l'effort.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Fatigue : ancienneté, rythme, retentissement
- Règles : abondance, durée (score de Higham), contraception
- Alimentation : sources de fer, thé ou café aux repas
- Signes d'appel : pâleur, chute de cheveux, ongles cassants, jambes sans repos, pica
- Saignements digestifs, AINS, IPP, dons du sang, projet de grossesse

10 ♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Carence martiale

Règles abondantes (8 jours, protections changées toutes les 2 heures). Pâleur conjonctivale.

? Quelles hypothèses formulez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Carence martiale, avec ou sans anémie, par pertes (ménorragies) et apports insuffisants
- Mécanismes : pertes > apports, malabsorption, besoins accrus
- Différentiels : hypothyroïdie, dépression, autre cause d'anémie
- Cause gynécologique : fibrome, adénomyose, trouble de l'hémostase

10 ♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Carence martiale

Hb 10,2 g/dL, VGM 74 fL, CRP normale.

? Quel examen confirme la carence ? Comment l'interpréter ?

REPÈRES ATTENDUS

- Ferritine en 1re intention : basse (seuil souvent retenu < 30 µg/L) = carence martiale
- Si inflammation, ferritine faussement normale : coefficient de saturation de la transferrine (< 20 %)
- Anémie microcytaire hypochrome = carence déjà installée
- Étiologie : avis gynécologique ; sinon maladie cœliaque (IgA anti-transglutaminase), saignement digestif

10 ♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Carence martiale

Ferritine : 6 µg/L. Une échographie pelvienne est programmée.

? Quel traitement et quel suivi proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Fer oral à distance des repas, éventuellement un jour sur deux (meilleure absorption, moins de troubles digestifs)
- Informer : selles noires, troubles digestifs ; éviter thé et café autour de la prise
- NFS à 4–6 semaines ; poursuite jusqu'à reconstitution des réserves (ferritine, ~3 mois)
- Traiter la cause ; fer IV si intolérance, malabsorption ou échec
- Conseils alimentaires : fer héminique et non héminique, vitamine C

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ CŒUR · RECUEILLIR

BPCO : repérage

M. P., 60 ans, ancien maçon, fume un paquet par jour depuis 40 ans. Il « s'essouffle plus vite qu'avant ».

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Tabagisme (ici 40 paquets-années), expositions professionnelles (poussières, silice)
- Dyspnée : échelle mMRC, évolution, retentissement
- Toux, expectorations, bronchites hivernales, exacerbations
- Activité physique, poids, comorbidités cardiovasculaires

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

BPCO : repérage

Toux et crachats chaque matin depuis 3 ans, essoufflement en montant un étage (mMRC 2).

? Quelle hypothèse principale ? Quels diagnostics différentiels ?

REPÈRES ATTENDUS

- Hypothèse : BPCO (facteur de risque majeur + symptômes chroniques)
- Questionnaire de repérage HAS : toux, crachats, essoufflement, âge > 40 ans, tabac
- Différentiels : asthme, insuffisance cardiaque, cancer bronchique, dilatation des bronches
- Alerte : hémoptysie, amaigrissement, douleur thoracique

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

BPCO : repérage

Vous organisez une exploration fonctionnelle respiratoire.

? Quel résultat confirme le diagnostic ?

REPÈRES ATTENDUS

- Trouble ventilatoire obstructif persistant après bronchodilatateur : VEMS/CVF < 0,7
- Sévérité selon le VEMS : stades GOLD 1 à 4
- Mini-spiromètre (VEMS/VEM6) pour le repérage ; la spirométrie confirme
- Selon le contexte : radiographie thoracique, NFS, SpO_2

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

BPCO : repérage

VEMS/CVF post-bronchodilatateur 0,62 ; VEMS 68 % de la théorique (GOLD 2).

? Quelles actions prioritaires mettez-vous en place ?

REPÈRES ATTENDUS

- Arrêt du tabac : l'intervention la plus efficace sur l'évolution
- Vaccinations : grippe, Covid-19, pneumocoque, VRS selon le calendrier en vigueur
- Activité physique, réhabilitation respiratoire
- Bronchodilatateurs sur prescription ; éducation aux techniques d'inhalation
- Plan d'action écrit en cas d'exacerbation ; suivi spirométrique

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Dépistage des cancers

> *Mme G., 56 ans, consulte pour des lombalgies. Elle n'a « jamais fait de dépistage ».*

? Quelles données recueillez-vous pour orienter les dépistages ?

REPÈRES ATTENDUS

- Antécédents personnels et familiaux de cancer (sein, côlon, ovaire, utérus)
- Dépistages déjà réalisés et leurs dates
- Freins : peur, pudeur, accès, littératie en santé, croyances
- Facteurs de risque : tabac, alcool, surpoids, traitement hormonal

Raisonnement clinique en prévention · IPA

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Dépistage des cancers

> *Pas d'antécédent familial connu. Les courriers de l'Assurance maladie sont « restés dans un tiroir ».*

? Quels dépistages organisés la concernent ?

REPÈRES ATTENDUS

- Sein : mammographie + examen clinique tous les 2 ans, de 50 à 74 ans
- Côlon-rectum : test immunologique fécal tous les 2 ans, de 50 à 74 ans
- Col de l'utérus : test HPV tous les 5 ans, de 30 à 65 ans
- Risque moyen → dépistage organisé ; risque élevé → suivi spécifique

Raisonnement clinique en prévention · IPA

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Dépistage des cancers

> *Elle se souvient finalement que sa sœur a eu un cancer du côlon à 48 ans.*

? Qu'est-ce que cela change dans votre raisonnement ?

REPÈRES ATTENDUS

- Parent du 1er degré atteint avant 65 ans → risque élevé : coloscopie, et non test immunologique
- Coloscopie dès 45 ans ou 5 ans avant l'âge du diagnostic du cas index
- Ici : coloscopie à programmer sans attendre
- Rechercher d'autres cas familiaux (syndrome de Lynch → oncogénétique)

Raisonnement clinique en prévention · IPA

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Dépistage des cancers

> *Mme G. est inquiète et redoute la coloscopie.*

? Comment l'accompagnez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Écoute des craintes ; information claire, adaptée à sa littératie
- Explication du déroulé : préparation colique, anesthésie
- Orientation gastro-entérologue ; mammographie et test HPV en parallèle
- Décision partagée, outils d'aide à la décision
- Traçabilité et relance ; signes d'alerte à connaître

Raisonnement clinique en prévention · IPA

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

R ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Fragilité & chutes

> *M. F., 78 ans, vit avec son épouse. Il est tombé deux fois en six mois, sans blessure grave.*

? Quelles données recueillez-vous sur ces chutes ?

REPÈRES ATTENDUS

- Circonstances : lieu, heure, activité, malaise, perte de connaissance, temps au sol
- Médicaments : psychotropes, antihypertenseurs, nombre de molécules
- Vision, audition, marche ; peur de tomber
- Environnement : tapis, éclairage, escaliers, chaussage
- Alcool, nutrition, continence

R ♥

R ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Fragilité & chutes

> *Il prend 7 médicaments, dont un hypnotique. Il se lève difficilement de sa chaise.*

? Comment évaluez-vous son risque de nouvelle chute ?

REPÈRES ATTENDUS

- Chutes répétées = facteur de risque majeur ; repérage de la fragilité (Gérontopôle, critères de Fried)
- Timed Up and Go, appui unipodal (< 5 s), test de lever de chaise
- Hypothèses : iatrogénie, sarcopénie, hypotension orthostatique
- Gravité : traumatisme, impossibilité de se relever seul

R ♦

R ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Fragilité & chutes

> *Vous poursuivez l'examen clinique.*

? Que recherchez-vous à l'examen et en biologie ?

REPÈRES ATTENDUS

- Hypotension orthostatique : PA couché puis debout à 1 et 3 min (baisse ≥ 20 mmHg systolique ou ≥ 10 diastolique)
- Pieds, vision, examen neurologique, troubles cognitifs
- Vitamine D, NFS, ionogramme, glycémie, fonction rénale selon le contexte
- Risque fracturaire : ostéoporose (fracture antérieure, densitométrie)

R ♣

R ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Fragilité & chutes

> *Hypotension orthostatique retrouvée. Par peur de tomber, il sort de moins en moins.*

? Quelle intervention multifactorielle proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Révision médicamenteuse avec le médecin (déprescription de l'hypnotique)
- Activité physique : équilibre et renforcement (kinésithérapie)
- Aménagement du domicile (ergothérapeute), téléassistance
- Apprentissage du relever du sol ; prise en charge de la peur de chuter
- Lever progressif ; correction d'une carence en vitamine D ; suivi coordonné

R ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Risque cardiovasculaire global

M. A., 50 ans, fumeur, hypertendu traité, demande s'il « risque une crise cardiaque comme son frère ».

? Quelles données recueillez-vous pour évaluer son risque ?

REPÈRES ATTENDUS

- Accident cardiovasculaire précoce chez un parent du 1er degré (homme < 55 ans, femme < 65 ans)
- Facteurs de risque : tabac, HTA, diabète, dyslipidémie, obésité, sédentarité
- Alimentation, alcool, stress, sommeil
- Symptômes : douleur thoracique d'effort, claudication, dyspnée

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Risque cardiovasculaire global

PA 136/84 mmHg sous traitement, LDL-c 1,9 g/L. Non diabétique, sans maladie cardiovasculaire connue.

? Quel outil utilisez-vous pour estimer son risque ?

REPÈRES ATTENDUS

- SCORE2 (ESC 2021) : risque d'événement cardiovasculaire à 10 ans, de 40 à 69 ans (SCORE2-OP au-delà)
- Variables : âge, sexe, tabac, PA systolique, cholestérol non-HDL, région
- Risque majoré par l'hérédité, l'obésité, la précarité
- Prévention secondaire, diabète, maladie rénale : outils et objectifs spécifiques

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Risque cardiovasculaire global

Son risque SCORE2 est estimé élevé.

? Quels examens complètent votre évaluation ?

REPÈRES ATTENDUS

- Bilan lipidique complet, glycémie à jeun ou HbA1c
- Créatininémie, DFG, ratio albuminurie/créatininurie
- ECG ; IMC, tour de taille
- LDL-c ≥ 1,9 g/L : évoquer une hypercholestérolémie familiale
- Atteinte d'organe asymptomatique (IPS, doppler) selon le contexte, sur avis médical

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Risque cardiovasculaire global

M. A. veut « tout changer d'un coup ».

? Comment priorisez-vous les actions avec lui ?

REPÈRES ATTENDUS

- Arrêt du tabac : le bénéfice le plus important
- Décision partagée : 1 ou 2 objectifs à la fois, réalistes et mesurables
- Alimentation de type méditerranéen, activité physique, contrôle tensionnel
- Statine selon l'objectif de LDL-c fixé par le niveau de risque, sur prescription
- Suivi régulier, renforcement positif ; dépistage familial si forme familiale

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

JOKER

JOKER 1

Drapeau rouge

Choisissez une thématique et citez au moins deux signes d'alerte qui imposent une orientation urgente.

Si le groupe valide, ce joker remplace n'importe quelle carte manquante d'un carré.

JOKER

JOKER

JOKER 2

Patient partenaire

Reprenez la dernière question jouée du point de vue du patient : ses priorités, ses craintes, ses préférences, ses savoirs expérientiels.

Si le groupe valide, ce joker remplace n'importe quelle carte manquante d'un carré.

JOKER

Aide-mémoire · les couleurs

Chaque couleur est une étape du raisonnement.

♥ **Cœur · Recueillir**
Anamnèse, écoute, contexte de vie

♦ **Carreau · Repérer & hypothèses**
Outils de repérage, scores, hypothèses diagnostiques

♣ **Trèfle · Vérifier**
Examen clinique, examens complémentaires, diagnostics différentiels

♠ **Pique · Agir & suivre**
Décision partagée, intervention, orientation, suivi

Un **carré** (les 4 couleurs d'une même valeur) = un raisonnement complet sur un même patient.

Aide-mémoire · les thématiques

Chaque valeur suit un même patient à travers les 4 étapes.

2	Sevrage tabagique
3	Alcool
4	Cannabis & autres substances
5	Hypertension artérielle
6	Diabète de type 2
7	Obésité & activité physique
8	Syndrome dépressif
9	Dénutrition de la personne âgée
10	Carence martiale
V	BPCO : repérage
D	Dépistage des cancers
R	Fragilité & chutes
A	Risque cardiovasculaire global

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

PRÉVENTION

IPA · Master